

Chapitre 2 : L'ÉLABORATION DES POLITIQUES SOCIALES

I. D'UNE PRIORITÉ SOCIALE A UNE POLITIQUE SOCIALE

A. Les Etapes D'élaboration

Pour apporter des réponses adaptées aux problèmes sociaux, des politiques sociales sont élaborées aux niveaux national et local. Quel que soit le niveau, l'enchaînement des étapes est toujours le même, celui d'une démarche de projet.

1. Le besoin social

La prise en compte des besoins individuels est un fondement historique des pratiques d'assistance [...]. Lorsque l'on passe au besoin social, on effectue un triple mouvement. Le besoin ne relève plus ici de l'individu X, il a une dimension plus collective ; [...] il ne peut se repérer de la même manière : la technique du repérage change ; enfin il ne relève plus tant de l'action du salarié au guichet ou dans son bureau que de celle du politique qui doit proposer une action en réponse aux besoins sociaux.

Marc Fourdrignier, « Une référence croissante aux besoins sociaux », 27 octobre 2017.

➤ **Donnez une définition en relevant les caractéristiques d'un besoin social.**

Un besoin social est un manque ressenti par un groupe de personnes, reconnu par la collectivité et pour lequel une réponse doit être apportée par les pouvoirs publics, par exemple la scolarisation des enfants handicapés, l'insertion professionnelle des jeunes, des ressources insuffisantes pour satisfaire les besoins fondamentaux...

Exemple : Quelques chiffres clés du grand âge en France

<https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/consultation-place-des-personnes-agees/concertation-grand-age-et-autonomie/article/grand-age-et-autonomie-les-chiffres-cles>

GRAND ÂGE ET AUTONOMIE : LES CHIFFRES CLÉS

Démographie



4,8 millions

de personnes de 85 ans et plus en 2050.

x3,2

augmentation du nombre de personnes de 85 ans et plus entre 2017 et 2050.

Perte d'autonomie



2,2 millions

de personnes en perte d'autonomie en 2050, contre 1,3 million en 2017.

40% des personnes qui déclinent en France ont connu la perte d'autonomie.

Dépenses publiques



30 Mds €

consacrés à la prise en charge de la perte d'autonomie en 2014, dont 80% de dépenses publiques.

Métiers du grand âge



830 000 équivalent temps plein employés auprès de personnes âgées en perte d'autonomie.

63 % des EHPAD déclarent avoir au moins un poste non pourvu depuis 6 mois ou plus.

Accompagnement à domicile



760 000 personnes âgées bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile.

60 % des bénéficiaires de l'APA vivent à leur domicile.

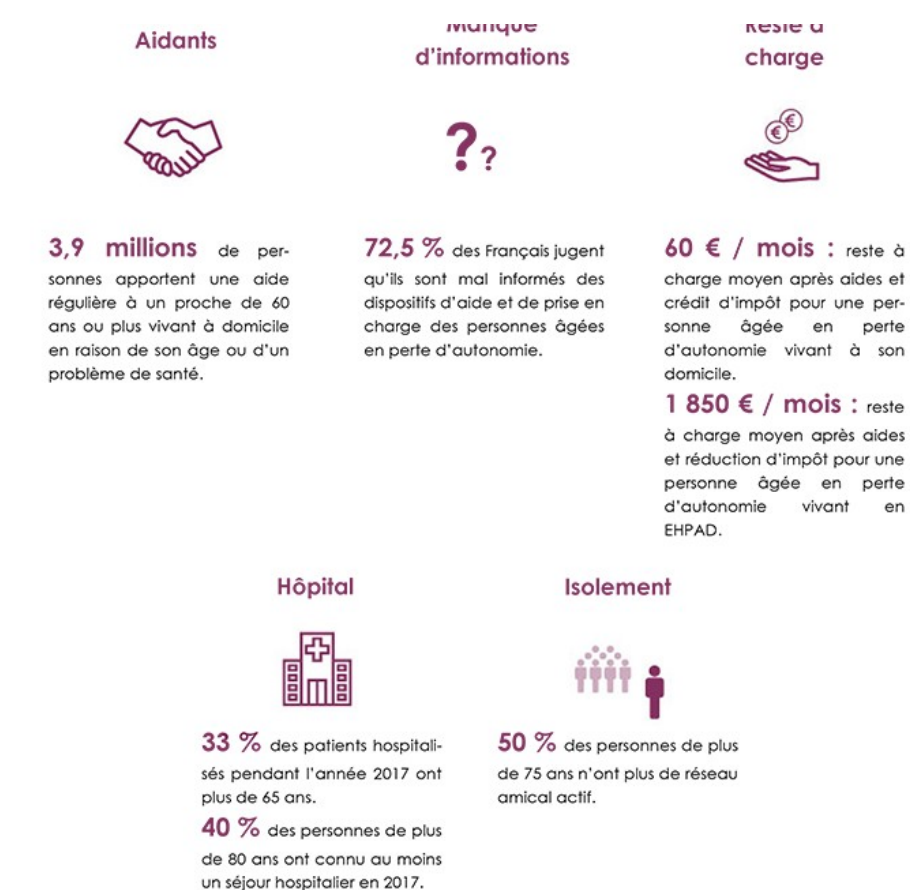
Accompagnement en EHPAD



21 % des personnes de plus de 85 ans vivent en établissement.

7 573 EHPAD accueillent chaque année 608 000 résidents.

50 % des places en EHPAD dans le secteur public, 28 % dans le secteur privé non lucratif, 22 % dans le secteur privé lucratif.



➤ **Quels sont les problèmes mis en évidence ?**

Problème lié à la démographie : nombre de personnes de +85 ans va être multiplié par 3.2 compliquant la prise en charge.

Problème lié au recrutement : l'augmentation des personnes en perte d'autonomie conduit à un besoin important de personnel.

Problème lié à l'hébergement : peu de place en EHPAD, un reste à charge plus élevé que dans le cas du maintien à domicile

➤ **La prise en charge des personnes dépendantes est-elle un besoin social ?**

Illustrez votre réponse.

Oui, elle est un besoin social car nous avons un manque de ressenti par **un groupe de personnes** (les personnes âgées) **reconnu par la collectivité et pour lequel une réponse doit être apportée** par les pouvoirs publics.

Oui, ce besoin concerne un **nombre important de personnes âgées dépendantes**, soit 1,3 Millions de personnes en 2017 et 2,2 million en 2050. **La prise en charge est en grande partie financée par l'État**, soit 80 % des 30 milliards d'euros en 2014. Ce sont des organismes nationaux de recueils de données (tels que la DREES) qui ont permis de repérer ce besoin (mode de repérage basé sur une analyse de grande ampleur).

Quelle différence entre besoin social et problème social ?

Un problème social est caractérisé par :

- Nombre important de personnes touchées par le problème
- Conséquence individuelles :
 1. Rupture des liens sociaux
 2. Besoins fondamentaux non satisfaits
- Conséquences collective : Impact sur la cohésion sociale : inégalités, incivilités/violences...

Un problème social affecte négativement les individus et peut avoir des conséquences graves sur les individus. Alors qu'un besoin social est un manque ressenti qui permet aux individus de vivre dignement.

Ainsi un besoin social qui n'est pas satisfait peut devenir un problème social.

2. Les priorités sociales

Les options de l'établissement des priorités : Les besoins sociaux sont nombreux, mais les ressources sont limitées. Souvent, les pays ont un espace fiscal limité, insuffisant pour couvrir tous les investissements nécessaires. La clef pour n'importe quelle stratégie c'est l'établissement des priorités, les ressources limitées sont donc dirigées vers les interventions qui ont des impacts plus grands et qui sont économiques.

Faire des choix de politiques est difficile. Ceci exige une évaluation des concessions réciproques à l'intérieur et à travers les secteurs, ayant une vision claire des contributions des différents programmes au développement, et leur coût efficacité, gouvernance, et la durabilité (Catégorie 7).

Etant donné que la plupart des pays en développement ont un espace fiscal et une capacité de mise en œuvre limités, le moment et l'étape choisis des politiques est important. La plupart des pays ont augmenté leur couverture des programmes sociaux progressivement (voir les sections sur les politiques universelles, et les options pour l'augmentation de la couverture); étant donné l'impératif urgent pour réduire la pauvreté, s'engager à un choix de moment ambitieux est essentiel pour une stratégie de développement nationale équitable.

➤ **Donnez une définition d'une priorité sociale.**

Un besoin social ou un problème social devient une **priorité sociale** lorsqu'il doit être satisfait avant tout autre du fait de la gravité du problème et de l'urgence de la réponse.

Une priorité sociale est avant tout un problème social :

- nombre important de personnes touchées par le problème
- 1. Rupture des liens sociaux
- 2. Besoins fondamentaux non satisfaits
- Impact sur la cohésion sociale (expliquer en quoi le problème crée des inégalités sociales)

➤ **Quels sont les critères pris en compte pour le choix d'une priorité sociale ?**

Une priorité sociale est donc caractérisée par un nombre important de personnes touchées, la nécessité d'apporter une réponse du fait de conséquences trop importantes sur la société.

➤ **Pourquoi les gouvernements sont-ils amenés à faire des priorités ?**

- **L'intervention de l'État est nécessaire mais va dépendre du coût et de l'efficacité de l'intervention.**

B. L'élaboration D'une Politique Sociale Au Niveau National

1. Des organismes qui participent à l'élaboration des politiques sociales

Depuis quelques années, l'État développe des partenariats avec des associations spécialisées dans la lutte contre l'exclusion et la pauvreté (ATD Quart Monde, Emmaüs, FNARS, UNIOPSS) pour avoir le point de vue des acteurs de terrain et prendre des décisions plus ciblées sur les domaines d'intervention prioritaires. De nombreux conseils ont été créés comme le Conseil national de lutte contre l'exclusion (CNLE), en 1988, ou l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES), en 1998, qui visent à réunir tous les acteurs étatiques et non étatiques spécialisés autour des questions sociales et à rendre un avis consensuel et neutre au gouvernement.

CNLE, « La mise en place progressive des minima sociaux », cnle.gouv.fr, 28 mars 2012.

- **Relevez les organismes qui aident le gouvernement à choisir les priorités sociales.**

Associations spécialisées dans la lutte contre l'exclusion et la pauvreté (ATD Quart Monde, Emmaüs, FNARS, UNIOPSS)

Conseil national de lutte contre l'exclusion (CNLE), en 1988, ou l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES), en 1998 qui sont des organismes indépendants (neutre et objectif).

Les associations spécialisées sont issues du terrain, elles sont en contact avec les populations en difficultés.

Les Conseils sont plus liés à l'étude : ils établissent des études et rédigent des rapports qui serviront à mieux connaître la situation.

- **Quel intérêt représente la diversité des organismes pour le choix des priorités ?**

Les différents conseils sont neutres mais éloignés du terrain alors que les associations apportent des informations issues du terrain car ils sont en contact avec les populations.

2. La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

La [...] DGCS est une direction d'administration centrale [...] gérée sur un plan administratif par le ministère en charge des affaires sociales [...]. La DGCS a pour mission de concevoir, piloter et évaluer les politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l'égalité, afin de favoriser la cohésion sociale et le soutien à l'autonomie des personnes. [...] La DGCS participe au pilotage de réseaux territoriaux : [...] les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale, qui sont les Directions régionales (et départementales) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et les Directions départementales de la cohésion sociale, ou de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS/DDCSPP).

Ministère des Solidarités et de la Santé, « DGCS », solidarites-sante.gouv.fr, 3 septembre 2019.

- **Relevez les acteurs de l'élaboration des politiques sociales.**

Au niveau national : La DGCS est gérée par le ministère des affaires sociales : **conçoit et évalue les politiques sociales.**

Elle pilote le réseau des directions au niveau régional : les DRJSCS et au niveau départemental : les DDCS.

- **Comment l'État peut-il veiller à la cohérence nationale et territoriale des politiques sociales ?**

Au niveau national, c'est la DGCS, direction de l'administration centrale, qui conçoit les politiques de l'État mises en œuvre ensuite dans toute la France par les services déconcentrés (au niveau régional par les DRJSCS et au niveau départemental par les DDCS). Or, cela garantit bien la cohérence des politiques dans tout le territoire.

3. L'État et les collectivités territoriales

« Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux autres organismes de sécurité sociale. »

Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

L'État est présent à Paris, c'est l'administration centrale, mais aussi sur tout le territoire français, sous la forme de services déconcentrés. Ces services mettent en œuvre les décisions prises par l'administration centrale et le personnel est nommé par cette dernière. Les collectivités territoriales (régions, départements et communes) sont des services décentralisés. La décentralisation est un mode d'administration qui transfère des compétences de l'administration centrale vers les collectivités territoriales. Pour cela, elles disposent d'une assemblée délibérative élue par la population pour les prises de décisions (conseil régional, départemental ou municipal) et d'un budget propre.

Conseil régional Occitanie

- **Relevez les différentes institutions compétentes pour définir la politique d'action sociale.**

Etat, collectivités territoriales dont le département en priorité, et organismes de sécurité sociale.

- **Présentez les trois modes d'administration qui coexistent en France.**

La centralisation, la déconcentration et la décentralisation

- **Relevez les caractéristiques de la déconcentration et celles de la décentralisation.**

La déconcentration : service de l'État dispersés dans les territoires : Préfectures, DRJSCS... Le personnel est nommé et rémunéré par l'État.

La décentralisation : pouvoirs transférés de l'État vers des collectivités territoriales : commune, région... elles sont la capacité de décision et de mettre en place des politiques propres.

Centralisation : les pouvoirs sont concentrés au sein de l'État

4. La place de l'utilisateur dans l'élaboration des politiques sociales

De manière générale, le terme « participation » désigne des tentatives de donner un rôle aux individus dans une prise de décision affectant une communauté. Au niveau de la mise en œuvre de politiques, l'expression « participation » renvoie au fait de prendre part à une action collective.

Pour les personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale, participer représente une occasion de donner son avis, de faire connaître ses conditions de vie, de témoigner de son expérience.

Et pour les acteurs professionnels, elle peut conduire à une amélioration des politiques et des lois conduites en se rapprochant au plus près des besoins et des attentes de la population concernée.

Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale,
« Définition de la participation », 3 août 2015.

➤ Illustrer les différentes possibilités de participation.

Ce peut être le fait de participer à une prise de décision qui concerne la collectivité, ou le simple fait de donner son avis du fait de son expérience ou de son vécu.

Les acteurs professionnels (associations, collectifs...) participent dans le but d'améliorer les politiques afin qu'elles répondent au mieux aux besoins de la population.

➤ Présenter les enjeux pour les individus, les acteurs bénévoles et les professionnels de ces participations.

Permettre une prise en compte des besoins réels de la population.

A partir de ce repérage, il sera possible d'adapter les actions.

L'implication des différents acteurs dans l'élaboration d'une stratégie nationale

Personnes en situation de pauvreté, travailleurs sociaux, responsables associatifs, élus locaux : la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté a été élaborée avec l'ensemble des acteurs. L'objectif : « impulser une véritable démocratie sociale » pour transformer durablement les pratiques et redonner le pouvoir d'agir aux personnes fragiles. Une dizaine de journées de concertation se sont tenues dans des territoires très différents, riches d'échanges avec les personnes concernées et les acteurs territoriaux mais aussi de découvertes de dispositifs opérationnels. Ces temps de concertation ont permis la rencontre de quelque 2 000 acteurs et la visite de plus de 40 structures.

Les personnes concernées ont été associées à chaque temps et chaque étape de concertation. De mi-janvier à fin février, une consultation en ligne a été lancée afin

d'impliquer le grand public dans la construction de la stratégie pauvreté. Cette consultation a permis de recueillir 7 200 contributions en moins de 6 semaines dont 3 200 provenant de personnes ayant vécu ou vivant une situation de pauvreté. Les répondants ont notamment appelé les pouvoirs publics à agir sur plusieurs leviers dont l'aide aux jeunes sans emploi, l'éducation et la formation des jeunes, l'accès aux services sociaux et la rénovation des métiers du travail social. Entre janvier et mars 2018, six groupes de travail thématiques [...] ont été formés pour réfléchir à la stratégie pauvreté et mener des auditions. Ces groupes de travail ont remis leurs propositions à Agnès Buzyn le 15 mars. C'est à partir de ces contributions que la stratégie pauvreté a été élaborée.

« Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté », dossier de presse, 13 septembre 2018.

- **Identifier l'utilité d'impliquer les personnes concernées dans la mise en place de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.**

Impliquer les personnes concernées dans la mise en place de la stratégie permet d'agir sur les leviers correspondant aux besoins de la population.

La stratégie de lutte contre la pauvreté s'appuie sur le concept de démocratie sociale : donner la possibilité aux usagers de participer à l'élaboration des politiques en donnant leur avis et ainsi faire respecter leurs droits.

- **Formuler des hypothèses pouvant expliquer des limites de cette implication.**

L'implication des personnes concernées peut se trouver freinée par un manque de motivation, une méconnaissance de la démarche, un manque d'accès aux outils nécessaires à la consultation en ligne (fracture numérique), des difficultés à comprendre les enjeux, le sentiment que sa contribution ne servira à rien...

- **Comment élabore t-on une politique sociale au niveau national ?**

La démarche d'élaboration des politiques sociales correspond aux étapes d'une démarche de projet :

Au niveau national : C'est la Direction Générale de la Cohésion Sociale qui dépend du ministère de la santé et des affaires sociales qui élabore et évalue. Elle s'appuie sur les directions régionales et départementales.

➔ **le diagnostic des besoins sociaux** : à partir des besoins sociaux et des problèmes sociaux, nous allons déterminer les priorités sociales.

➔ **le choix des priorités** : consultation des partenaires (associations spécialisées et conseils) mais aussi des usagers ce qui caractérise la **démocratie sociale**.

➔ La détermination des objectifs.

➔ la définition du plan d'action (mesures, acteurs, financement, échéancier).

➔ mise en œuvre de la politique/utilisation d'outils de suivi.

➔ Évaluation de la politique.

C. L'élaboration des politiques au niveau départemental

1. Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale

Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec [le schéma régional de santé prévu l'article L. 1434-2 du code de la santé publique](#) :

1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;

2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;

3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ;

4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article [L. 312-1](#), à l'exception des structures expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis à l'[article L. 6111-1 du code de la santé publique](#) ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ;

5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.

Les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et les centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 contribuent, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l'élaboration des schémas d'organisation sociale et médico-sociale et des schémas régionaux de santé, à l'analyse des besoins et de l'offre mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi qu'à toute action liée à la mise en oeuvre de ces schémas.

Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°.

Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l'initiative de l'autorité compétente pour l'adopter.

Le conseil départemental est [...] positionné comme chef de file de l'action sociale et médico-sociale. À ce titre, il a en charge le renouvellement du schéma d'organisation sociale et médico-sociale, dont un volet est consacré aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. [...] Ce schéma a ainsi vocation à déterminer le niveau des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, à dresser un bilan de l'offre sociale et médico-sociale existante et à faire état des besoins de développement de l'offre (notamment les créations, transformations ou suppressions d'établissements et services).

➤ Qui est responsable de l'élaboration des politiques sociales au niveau départemental ?

Le conseil départemental, il est le chef de file de l'action sociale et médico-sociale et est responsable des politiques sociales sur cet échelon.

➤ Quelles informations figurent dans un schéma d'organisation sociale et médico-sociale ?

Le bilan du précédent schéma, les besoins sociaux et médico-sociaux de la population, l'offre sociale et médico-sociale existante, les besoins en établissement et services, les objectifs de développement de l'offre et les critères d'évaluation

➤ Quel est l'objectif du schéma d'organisation sociale et médico-sociale.

Faire un état des lieux des besoins sociaux et médico-sociaux.

Faire le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre sociale et médico-sociale.

- Déterminer les objectifs de développement de l'offre pour la période à venir afin de répondre au mieux aux besoins de la population.

2. Les trois étapes de l'élaboration du schéma départemental de l'autonomie

Trois étapes clés

Première étape

Elle a consisté à réaliser le **bilan du précédent schéma 2012-2016**, à analyser l'impact de la mise en œuvre des lois de 2007 et 2016 sur les pratiques professionnelles et à dresser un état des lieux du dispositif départemental, sur la base de l'analyse de chiffres-clés.

Ces travaux ont notamment conduit à :

- ◆ Elaborer un diagnostic détaillé de la politique départementale de protection de l'enfance
- ◆ Identifier des orientations stratégiques à mettre en œuvre pour les prochaines années.

Deuxième étape

Elle a été consacrée à l'organisation d'une **large concertation partenariale** avec l'ensemble des acteurs agissant dans le champ de la protection de l'enfance, qu'ils soient agents du Département ou professionnels intervenant sur le territoire. Le lancement de l'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance du Haut-Rhin a concrétisé cette phase active de concertation.

Ces travaux ont conduit à :

- ◆ Partager des constats
- ◆ Dégager les principaux enjeux d'aujourd'hui et de demain en protection de l'enfance.

Dernière étape

Elle a été dédiée à la **rédaction** du projet du Schéma et à la **définition de ses modalités de pilotage** pour assurer sa mise en œuvre, à l'appui d'une programmation annuelle des actions.

Cette programmation pourra évoluer afin de s'adapter au plus près des besoins et des situations. 5 actions sont prévues pour 2019 dont 3 de manière concomitante au lancement du Schéma.

<https://www.hautrhin.fr/sites/cea/files/Sche%CC%81ma%20de%CC%81partemental%202019-2023.pdf>

- Commentez les trois étapes d'élaboration de ce schéma départemental pour la protection de l'enfance en mettant en évidence leur intérêt.

Etape 1 : première étape de l'élaboration

- Relevez les éléments qui permettent d'affirmer que la méthode d'élaboration est fortement participative.
- Quelle est la fréquence à laquelle un schéma doit être renouvelé ?

D. L'élaboration d'une politique au niveau communal

1. L'analyse des besoins sociaux

<https://www.youtube.com/watch?v=gJG-8NYXpLo>

Qu'est-ce que l'analyse des besoins sociaux ?

Quel est son rôle et son utilité ?

2. Méthodologie d'élaboration de l'analyse des besoins sociaux de la commune de Pont de Claix 2017/2018

3-1 Recueil et ordonnancement des données statistiques

- Données de contexte : recensements 2009 et 2014 de INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) et CAF (Caisse d'Allocations Familiales).

Les données du recensement de la population sont celles disponibles au moment de la finalisation de l'ABS. Ce sont les données millésimées 2014 (RP 2014). Avec la nouvelle méthode de recensement, elles résultent du traitement statistique des données recueillies par sondage sur 5 années d'enquête, entre 2012 et 2016. Les évolutions sont calculées par rapport aux données millésimées 2009 (RP 2009) sur les 5 années d'enquêtes de 2008 à 2012.

- Données administratives des partenaires institutionnels et autres acteurs locaux: Département, Mission Locale, etc.

3-2 Rapports et études

L'ABS s'appuie également sur des données issues de rapports et d'études :

- Plan local d'Urbanisme de Pont de Claix, Septembre 2016 ,
- Regards Croisés de l'Obsy « La santé des habitants de la Métropole grenobloise » Juillet 2015,
- « Rapport d'Évaluation de la politique communale en direction des personnes âgées », 2016,
- « Diagnostic jeunesse » octobre 2018,
- « Commission d'évaluation de la DSP », février 2018.

3-3 Les tableaux de bords internes

Bilans, indicateurs d'activité, etc... dans les différents services lorsque cela est nécessaire et pertinent.

3-4 L'analyse infra-communale

L'analyse infra-communale se fera au niveau des IRIS (Îlots Regroupés pour l'Information Statistique) de l'INSEE.

- **Quels sont les acteurs sollicités pour établir les besoins sociaux?**
- **Pourquoi peut-on dire que ce diagnostic est un diagnostic partagé ?**
- **Quel est l'intérêt d'un diagnostic partagé ?**

3. Intérêt de l'ABS

Les éléments clés du diagnostic du CCAS de Seyssinet-Pariset

Analyse des besoins sociaux et anticipation des évolutions de la société



« Le recueil d'analyse et de données ainsi que des entretiens, des questionnaires et des séminaires – soit au total 370 contributions auprès d'habitants, élus, services de la ville, partenaires associatifs et institutionnels – ont permis d'établir le diagnostic des réalités de la vie quotidienne des Seyssinettois », résume Hélène Boissel, directrice du CCAS et coordinatrice de la démarche.

Les éléments clés de ce diagnostic

Des difficultés repérées pour les jeunes avec 13,7 % d'entre eux à la recherche d'un emploi et un taux de chômage atteignant les 30 % (en 2011), une augmentation importante à venir ces prochaines années du nombre de personnes de plus de 80 ans, un niveau de vie globalement meilleur que dans d'autres communes de l'agglomération, des indicateurs liés à l'activité, la formation et l'emploi globalement positifs.

En fonction des enjeux identifiés comme prioritaires, des projets et des plans d'actions ont été définis en faveur des jeunes et des personnes âgées.

• **Jeunes** : les accompagner vers l'autonomie, l'activité et l'emploi [...]. Parmi les objectifs recherchés : le soutien des parents dans l'éducation, l'identification des jeunes comme des ressources, le développement du lien intergénérationnel ou encore l'accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle comme dans leur projet de vie. Parmi les actions envisagées : la création d'un groupe ressource d'acteurs, de professionnels et de bénévoles agissant dans le champ de la jeunesse ou encore l'organisation de chantiers solidaires chez des personnes âgées.

• **Personnes âgées** : favoriser leur bien vivre à Seyssinet-Pariset. [...] Parmi les actions envisagées : la coordination d'acteurs et de bénévoles agissant auprès de personnes âgées ou encore la création d'un réseau de bénévoles de proximité.

« Anticiper les évolutions de la société », *La Gazette*, journal municipal de Seyssinet-Pariset [38], n° 137, déc. 2015.

- Montrer l'intérêt d'une analyse des besoins dans l'élaboration de la politique sociale communale de Seyssinet-Pariset.